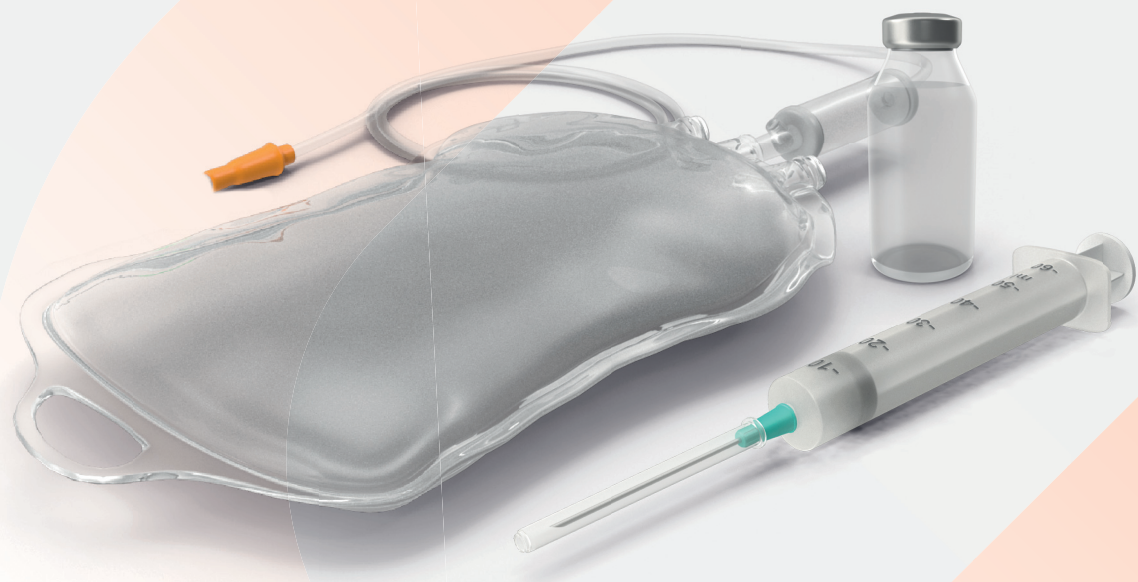


DILUCIONES ESTANDARIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS Y REANIMACIÓN PARA PERFUSIONES CONTINUAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO



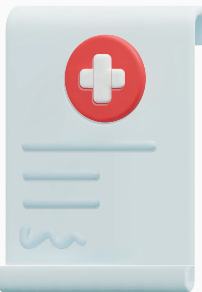
MEDICAMENTO
ALTO
RIESGO

Revisión
Junio, 2026

MEDICAMENTO	PREPARACIÓN	CONCENTRACIÓN	PRINCIPALES PRECAUCIONES
ADRENALINA (EPINEFRINA) Adrenalina® amp 1 mg/1 mL	10 mg en 100 mL de SG5%	0,1 mg /mL	Administrar protegido de la luz. Utilizar vía central.
AMIODARONA, clorhidrato Trangorex® amp 150 mg/3 mL	600 mg en 250 mL de SG5%	2,4 mg/mL	Incompatible con SF. Utilizar preferentemente vía central.
	UCIC: 900 mg en 250 mL SG5%	3,6 mg/mL	
ANGIOTENSINA II Giapreza® vial 2,5mg/1 mL	2,5 mg en 250 mL de SF	10 mcg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
CISATRACURIO, besilato Cisatracurio vial 10 mg/5 mL Cisatracurio amp 20 mg/10 mL	100 mg en 250 mL de SF	0,4 mg/mL	Incompatible con propofol.
DEXMEDETOMIDINA Dexmetomidina bolsa 400 mcg/100 mL	Listo para su uso	4 mcg/mL	
DOBUTAMINA Dobutamina vial 250 mg/20 mL	500 mg en 250 mL de SG5% NEUROCRÍTICOS: en SF	2 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
	UCIC: 400 mg en 100 mL de SF	4 mg/mL	
DOPAMINA, clorhidrato Dopamina amp 200 mg/5 mL	500 mg en 250 mL de SG5% NEUROCRÍTICOS: en SF	2 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
	UCIC: 1000 mg en 250 mL de SF	4 mg/mL	
EPOPROSTENOL Flolán® vial 0,5 mg (500 mcg + vial disolvente 50 mL)	250 mcg en 250 mL de SG5%	1 mcg/mL	Administrar protegido de la luz. Utilizar vía central si larga duración. Cambiar la preparación cada 12 h.
	UCIC: 500 mcg en 250 mL de SF	2 mcg/mL	
ESMOLOL, hidrocloreuro Brevibloc® bolsa 2,5 g/250 mL	Listo para su uso	10 mg/mL	Incompatible con bicarbonato sódico. Utilizar preferentemente vía central.
FENILEFRINA Fenilefrina bolsa 10 mg/100 mL	Listo para su uso	0,1 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
FENTANILO Fentanest® amp 0,15 mg/3 mL	0,9 mg en 100 mL de SG5% UCIC y NEUROCRÍTICOS: en SF	9 mcg/mL	
HEPARINA sódica Heparina 5 % vial 25.000 UI/ 5 mL	25.000 UI en 250 mL de SF	100 UI/mL	
INSULINA humana soluble Actrapid® vial 100 UI/mL (10 mL)	REANIMACIÓN: 50 UI en 100 mL de SF	0,5 UI/mL	
	100 UI en 100 mL de SF	1 UI/mL	
ISOPRENALINA, sulfato Isoprenalina amp 0,2 mg/1 mL	1 mg en 500 mL de SG5%	2 mcg/mL	
	UCIC: 1 mg 250 mL de SF	4 mcg/mL	
KETAMINA Ketolar® vial 500 mg/10 mL	500 mg en 500 mL de SF o SG5%	1 mg/mL	

UCIC = Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares; SF = Suero Fisiológico; SG5%= Suero Glucosado al 5%.

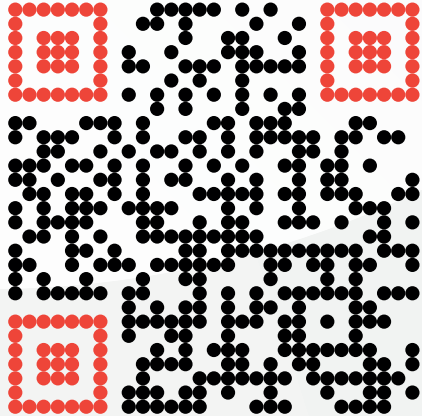
MEDICAMENTO	PREPARACIÓN	CONCENTRACIÓN	PRINCIPALES PRECAUCIONES
LABETALOL, clorhidrato Trandate® amp 100 mg/20 mL	1 g en 250 mL de SG 5% NEUROCRÍTICOS: en SF	4 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
LEVOSIMENDAN Simdax® vial 12,5 mg/5 mL	12,5 mg en 500 mL de SG5%	25 mcg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
LIDOCAINA, clorhidrato Lidocaína 5 % amp 250 mg/5 mL	1.000 mg en 250 mL de SG5%	4 mg/mL	
MAGNESIO, sulfato Sulmetín simple® amp 1,5 g/10 mL	15 g en 250 mL de SF	60 mg/mL	
MIDAZOLAM, hidrocloreuro Midazolam amp 50 mg/10 mL	250 mg en 250 mL de SG5% UCIC y NEUROCRÍTICOS: en SF	1 mg/mL	Verificar presentación correcta, porque hay varias disponibles en el hospital. Utilizar preferentemente vía central.
MILRINONA, lactato Corotrope® amp 10 mg/10 mL	20 mg en 100 mL de SG5% UCIC: en SF	0,2 mg/mL	Incompatible con bicarbonato sódico. Utilizar preferentemente vía central.
MORFINA, clorhidrato Morfina 1% amp 10 mg/1 mL	10 mg en 100 mL de SF	0,1 mg/mL	Verificar presentación correcta, porque hay varias disponibles en el hospital.
NITROPRUSIATO sódico Nitroprusiat® vial 50 mg + amp de disolvente con 5 mL SG5%	50 mg en 250 mL de SG5%	200 mcg/mL	Incompatible con SF. Administrar protegido de la luz.
L-NORADRENALINA (L-NOREPINEFRINA) Noradrenalina® amp 5 mg/ 10 mL	5 mg en 100 mL de SG5%	50 mcg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
PROPOFOL Propofol 1 % y 2% varias presentaciones	Listo para su uso	1% (10 mg/mL) 2% (20 mg/mL)	Cambiar la preparación cada 12 h. Incompatible con cisatracurio.
REMIFENTANILO Remifentanilo vial 5 mg (reconstituir con 5 mL de SG5%/SF)	5 mg en 100 mL de SG5% UCIC y NEUROCRÍTICOS: en SF	50 mcg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
ROCURONIO, bromuro Esmeron® vial 50 mg/5 mL	500 mg en 250 mL de SF	2 mg/mL	
SALBUTAMOL, sulfato Ventolín® amp 0,5 mg/1 mL	5 mg en 500 mL de SG5% NEUROCRÍTICOS: en SF	10 mcg/mL	
TIOPIENTAL sódico Tiobarbital® vial 1 g (reconstituir con 20 mL de SF)	2 g en 100 mL de SF	20 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
URAPIDILO, clorhidrato Urapidilo® amp 50 mg/10 mL	250 mg en 500 mL de SG5% UCIC y NEUROCRÍTICOS: en SF	0,5 mg/mL	Utilizar preferentemente vía central.
VASOPRESINA (ARGIPRESINA) Empressin® amp 40 UI/2 mL	40 UI en 100 mL de SF	0,4 UI/mL	
	UCIC: 40 UI en 50 mL de SF	0,8 UI/mL	



PRECAUCIONES GENERALES

- Realizar “*doble chequeo*” durante la fase de preparación de la perfusión. Mezclar bien antes de administrar.
- Etiquetar la preparación con: nombre del medicamento, concentración, fecha y hora de la preparación.
- Todas las perfusiones se cambian como máximo a las 24 horas de su preparación.

- Revisar la compatibilidad en Y para medicamentos y fluidos.
- La velocidad de administración depende del protocolo o respuesta clínica.
- Administrar con bomba de infusión inteligente que disponga de biblioteca de fármacos.



COMPLEJO
ASISTENCIAL
UNIVERSITARIO
D SALAMANCA

